

Douleur de genou

Le syndrome fémoro-patellaire

*Le plan simple pour soulager la douleur fémoro-patellaire
sans arrêter de courir.*



Maxence Lecointe

Ostéopathe D.O. — Expert Running — Lille

Introduction

Pourquoi ce guide ?

Si vous lisez ce guide, c'est probablement parce que votre genou vous freine dans la pratique de la course à pied.

Peut-être que la douleur revient régulièrement.

Peut-être que vous avez déjà essayé du repos, des exercices trouvés en ligne ou différents conseils contradictoires.

Et peut-être que vous avez surtout envie d'une chose : courir sereinement.

Qui suis-je ?

Je suis ostéopathe depuis 2015, installé à Lille depuis le début de mon activité. J'ai progressivement orienté ma pratique vers la prise en charge du coureur.

Au fil des années, j'ai accompagné des coureurs débutants, des sportifs en reprise après blessure, des athlètes préparant semi-marathon, marathon ou ultra, ainsi que des profils « sport santé » souhaitant simplement courir sans douleur.

Très vite, une évidence s'est imposée : la majorité des douleurs du coureur ne relèvent pas uniquement d'un trouble local. Elles relèvent souvent d'un déséquilibre entre la charge d'entraînement, la capacité tissulaire, la progression et la récupération.

Ma prise en charge du coureur : une approche globale

Au cabinet, mon accompagnement repose sur cinq piliers :

1. Analyse clinique et compréhension du contexte (historique de blessure, volume d'entraînement, progression récente, objectifs).
2. Évaluation de la charge (répartition hebdomadaire, intensité, variations brutales).
3. Analyse de foulée (observation sur tapis, compréhension des contraintes biomécaniques, mise en perspective sans sur-interprétation).
4. Renforcement ciblé et progressif (travail de capacité musculaire et de tolérance mécanique).
5. Planification du retour à la course (réintroduction structurée des volumes et intensités).

Ce guide est directement inspiré de cette méthodologie. Il ne remplace pas l'accompagnement individualisé, mais il en reprend la logique.

Avez-vous le bon guide ?

Avant de continuer, prenez 2 minutes pour vérifier que ce guide correspond bien à votre situation. Cochez mentalement les affirmations qui vous ressemblent.

Auto-diagnostic en 6 questions

- Ma douleur se situe à l'avant du genou, autour ou derrière la rotule.
- Elle apparaît ou s'aggrave pendant la course, en descente ou dans les escaliers.
- Elle est apparue après une augmentation de volume, d'intensité, ou un changement de terrain.
- Elle est plutôt sourde et diffuse — pas une douleur très localisée sur un point précis.
- Le repos seul a déjà été essayé, sans résolution durable.
- Je peux encore courir, ou je veux pouvoir continuer à courir intelligemment.

Si vous cochez 4 affirmations sur 6

Ce guide est probablement adapté à votre situation. La méthode présentée vous donnera un cadre clair pour gérer la douleur, structurer votre reprise, et continuer à courir sans aggraver.

Si vous cochez moins de 4 affirmations

Votre douleur ne ressemble pas typiquement à un syndrome fémoro-patellaire. Avant d'appliquer ce plan, il est plus prudent de consulter un professionnel pour préciser le diagnostic — un autre guide de la collection sera peut-être plus pertinent.

Drapeaux rouges : quand consulter sans attendre

La méthode présentée ici suppose une douleur fémoro-patellaire mécanique « classique ». Certains signes orientent vers d'autres pathologies qui nécessitent une évaluation médicale avant toute reprise structurée.

⚠️ CONSULTEZ SANS ATTENDRE SI :

- Douleur très intense (supérieure à 7/10) ou qui empire malgré le repos.
- Douleur nocturne ou présente au repos prolongé.
- Gonflement articulaire visible ou genou chaud au toucher.
- Sensation de blocage, de craquement avec dérobement, ou genou qui « lâche ».
- Trauma direct récent (chute, choc) à l'origine de la douleur.
- Fièvre associée à la douleur du genou.
- Antécédent de chirurgie du genou ou de pathologie inflammatoire connue.

Dans tous ces cas, ce guide ne suffit pas. Consultez votre médecin traitant, un médecin du sport, un kinésithérapeute ou un ostéopathe pour préciser le diagnostic. Vous pourrez reprendre ce plan ensuite, en complément de la prise en charge.

Ce que ce guide est, ce qu'il n'est pas

Ce guide est :

- Une base structurée et adaptable.
- Un cadre de progression sur 6 semaines.
- Une synthèse de principes éprouvés en cabinet.
- Un outil pour reprendre le contrôle de votre pratique.

Ce guide n'est pas :

- Un diagnostic médical personnalisé.
- Un protocole universel applicable à tous.
- Un substitut à une consultation.

Chaque coureur est unique. L'âge, l'historique sportif, la morphologie, la charge d'entraînement, le niveau de performance et les objectifs influencent la prise en charge. Si vous avez un doute, consultez.

À qui s'adresse ce plan ?

Vous êtes au bon endroit si :

- Vous avez une douleur à l'avant du genou.
- Vous continuez à courir, ou vous voulez continuer.
- Le repos seul n'a rien réglé durablement.
- Vous êtes perdu(e) entre des conseils contradictoires.

Ce guide n'est PAS fait pour vous si :

- Vous cherchez un diagnostic médical précis.
- Vous voulez un protocole de rééducation post-chirurgicale.
- Vous refusez d'adapter temporairement votre entraînement.

Principes du plan

10 à 15 minutes par séance. 3 séances par semaine. Sur 6 semaines. En continuant à courir intelligemment.

Partie 1 — Pourquoi ça fait mal et pourquoi ça dure ?

1. Cette douleur est fréquente chez le coureur

La douleur fémoro-patellaire (souvent appelée « genou du coureur ») se manifeste généralement à l'avant du genou, autour ou derrière la rotule, à la course, en descente ou en escaliers, après une augmentation de volume ou d'intensité.

Bonne nouvelle

Dans la grande majorité des cas, il ne s'agit pas d'un genou « abîmé ». Il s'agit d'un genou dépassé par la charge qu'on lui impose.

2. La vraie cause : un problème de tolérance à la charge

Votre genou supporte des milliers d'impacts à chaque sortie.

Le problème n'est pas le mouvement. Le problème n'est pas forcément votre foulée. Le problème n'est pas « une rotule mal placée ».

Le problème, c'est un déséquilibre entre :

- la charge imposée (volume, intensité, terrain, fatigue),
- la capacité actuelle de vos tissus à la supporter.

Quand la charge dépasse la capacité, la douleur apparaît. Si on baisse un peu la charge et qu'on augmente progressivement la capacité, la douleur diminue.

Objectif de la méthode

Stimuler suffisamment une structure pour augmenter sa capacité, sans dépasser sa tolérance actuelle.

3. Pourquoi le repos seul ne règle pas le problème

Beaucoup de coureurs font ceci : douleur → arrêt complet → reprise identique → retour de la douleur.

Le repos diminue l'irritation, mais il ne renforce pas la capacité du genou à encaisser la charge. Résultat : le coureur repart avec la même tolérance qu'avant.

Le but n'est pas d'éviter toute contrainte. Le but est de réadapter progressivement le genou à la contrainte.

4. Douleur ne signifie pas lésion

Une douleur à 2 ou 3/10 pendant l'effort ne signifie pas que vous êtes en train d'abîmer votre genou.

La douleur est souvent un signal de sensibilité accrue, pas une alarme de destruction. Elle reflète parfois une sensibilité du système, pas nécessairement une dégradation structurelle.

Ce qui compte vraiment :

- Est-ce que la douleur augmente fortement le lendemain ?
- Est-ce qu'elle devient plus fréquente ?
- Est-ce que la capacité diminue ?

Si la réponse est non, la zone de travail est probablement acceptable.

5. Les erreurs les plus fréquentes

1. Tout arrêter brutalement

Cela réduit temporairement la douleur, mais diminue aussi la tolérance à la charge.

2. Continuer exactement de la même façon

Ignorer la douleur et maintenir volume et intensité entretient l'irritation.

3. Modifier trop de variables en même temps

Chaussures, cadence, terrain, renforcement, volume... Impossible de savoir ce qui fonctionne.

4. Chercher la perfection biomécanique

Le corps s'adapte. Il n'existe pas une foulée parfaite universelle.

Partie 2 — Les règles pour progresser sans aggraver

Avant de commencer le plan d'exercices, il est essentiel de comprendre une chose :

Principe fondamental

Ce n'est pas l'exercice qui guérit. C'est la cohérence dans la gestion de la charge. En respectant ces règles, le genou progresse. En les ignorant, la douleur revient.

1. La règle de la douleur tolérable

Pendant les exercices ou la course, une gêne légère est acceptable. Une douleur $\leq 3/10$ est généralement tolérable.

On ne veut pas :

- Une douleur qui augmente fortement pendant la séance.
- Une douleur qui explose le lendemain.

Si la douleur augmente nettement le lendemain, la charge était trop élevée.

Douleur (échelle 0-10)	Conduite à tenir
0-3	Zone acceptable. On continue.
4-6	Prudence. Réduire le volume / l'intensité de la séance.
7+	Stop ou adaptation forte nécessaire.

2. Une seule variable à la fois

Quand l'entraînement évolue, on ne change qu'un seul paramètre : volume, intensité, dénivelé, fréquence ou type de séance.

On ne change pas chaussures + cadence + volume + exercices en même temps. Sinon, impossible de comprendre ce qui fonctionne.

3. Pas de double progression

On ne peut pas augmenter le volume de course ET la difficulté du renforcement au même moment. On choisit l'un ou l'autre. Priorité : stabiliser la douleur, puis progresser progressivement.

4. La règle des 20 %

Si la douleur augmente :

- On réduit le volume hebdomadaire d'environ 20 % de manière temporaire (7 à 14 jours).
- On garde une intensité modérée.
- On supprime temporairement les séances les plus agressives (descente, fractionné intense).

Inutile d'arrêter totalement. Il suffit souvent d'ajuster.

5. La constance prime sur l'intensité

Ce plan fonctionne en étant régulier, patient, cohérent. Il ne fonctionnera pas en faisant 3 séances la première semaine, puis rien pendant 10 jours, puis une séance très intense.

Le corps s'adapte à ce qui est répété.

6. Surveiller les bons indicateurs

Ne pas se focaliser uniquement sur la douleur. Observer aussi :

- La durée avant apparition de la gêne.
- La sensation de stabilité.
- La récupération le lendemain.
- La confiance à la course.

L'amélioration est souvent progressive, pas spectaculaire.

7. Le principe fondamental

On ne cherche pas à supprimer toute contrainte. On cherche à rendre le genou plus tolérant à la contrainte.

La progression n'est pas linéaire. Il y aura parfois des jours « avec » et des jours « sans ». Ce qui compte, c'est la tendance sur plusieurs semaines.

À retenir

Une douleur légère contrôlée est acceptable. Une seule variable progresse à la fois. Si la douleur augmente, on ajuste — on ne panique pas. La régularité est plus importante que l'intensité.

Partie 3 — Le plan anti-douleur sur 6 semaines

Pourquoi 6 semaines ? Parce que le tissu articulaire et le système neuromusculaire ont besoin d'environ 4 à 8 semaines pour augmenter significativement leur tolérance à la charge. Aller plus vite ne sert à rien ; aller moins vite n'apporte pas de bénéfice supplémentaire.

Avant de commencer

- 10 à 15 minutes par séance.
- 3 fois par semaine.
- Idéalement les jours sans séance intense.
- Objectif : augmenter la tolérance du genou.

Respecter les règles de la Partie 2 (douleur $\leq$ 3/10 à tout moment).

Exercice 1 — Squat contrôlé

Objectif : améliorer la tolérance du genou à la flexion en charge et renforcer la coordination hanche–genou.



Position de départ



Position basse

Mise en place

- Pieds largeur d'épaules.
- Pointes légèrement ouvertes.
- Regard horizontal.

Exécution

- Descendre lentement (3 secondes).
- Amplitude confortable, sans chercher à aller bas.
- Remonter de façon contrôlée.

Erreurs fréquentes

- Descendre trop vite.
- Genoux qui rentrent vers l'intérieur.
- Chercher l'amplitude maximale.

Progression

Semaines	Séries	Répétitions
1–2	3	8
3–4	3	10
5–6	3	12

Si trop facile : ralentir encore la descente. Si douleur > 3/10 : réduire les répétitions.

Exercice 2 — Step down

Objectif : améliorer le contrôle du genou lors des phases d'appui (descente, impact).



Position de départ



Position basse

Mise en place

- Debout sur une marche si possible (15 à 20 cm de hauteur).
- Pied bien ancré sur la marche.
- Bassin stable, regard horizontal.

Exécution

- Descendre lentement le talon vers le sol (3 secondes).
- Garder le genou aligné avec le pied.
- Effleurer le sol avec le talon, puis remonter en contrôlant.

Erreurs fréquentes

- Genou qui rentre vers l'intérieur.
- Descente rapide / non contrôlée.
- Amplitude trop élevée trop tôt (marche trop haute).

Progression

Semaines	Séries	Répétitions
1–2	3	6 / côté
3–4	3	8 / côté
5–6	3	10 / côté

Exercice 3 — Fente avant contrôlée

Objectif : renforcer la chaîne hanche–genou en charge unilatérale tout en travaillant le contrôle du genou avant — composante clé pour le syndrome fémoro-patellaire.



Position de départ



Position basse

Mise en place

- Debout, pieds écartés à largeur de bassin.
- Buste droit, regard horizontal.
- Mains sur les hanches ou le long du corps.

Exécution

- Faire un grand pas vers l'avant.
- Descendre lentement (3 secondes) jusqu'à ce que le genou arrière effleure le sol.
- Genou avant aligné avec le pied — pas vers l'intérieur.
- Remonter en poussant sur le talon avant.

Erreurs fréquentes

- Genou avant qui rentre vers l'intérieur.
- Tronc penché vers l'avant.
- Pas trop court — surcharge accrue sur l'avant du genou.
- Mouvement trop rapide.

Variante alternative : fente arrière (recule la jambe au lieu d'avancer) — moins de contrainte sur le genou avant si la douleur est trop élevée.

Progression

Semaines	Séries	Répétitions
1-2	3	6 / côté
3-4	3	8 / côté
5-6	3	10 / côté

Exercice 4 — Pont fessier unilatéral

Objectif : améliorer la stabilité du bassin à l'appui — composante clé du contrôle du genou.



Position de départ



Position haute (pont)

Mise en place

- Allongé sur le dos.
- Une jambe fléchie, pied à plat au sol.
- L'autre jambe tendue dans l'axe du corps.

Exécution

- Monter le bassin lentement.
- Maintenir 1 seconde en position haute.
- Redescente contrôlée.

Erreurs fréquentes

- Bassin qui bascule sur le côté.
- Monter trop vite.
- Compensations lombaires (cambrer fortement le dos).

Progression

Semaines	Séries	Répétitions
1–2	3	5 / côté
3–4	3	7 / côté
5–6	3	10 / côté

Exercice 5 — Gainage latéral

Objectif : renforcer la stabilité latérale et limiter le stress frontal sur le genou.

Mise en place

- Corps aligné, sur le côté.
- Coude sous l'épaule.
- Ventre légèrement rentré.

Exécution

- Maintenir la position stable.
- Respirer normalement, pas en apnée.

Progression



Position de départ



Position tenue

Semaines	Séries	Durée
1-2	3	20 sec
3-4	3	30 sec
5-6	3	40 sec

Exercice 6 — Mollets unilatéraux

Objectif : améliorer la gestion de la charge à l'impact.

Mise en place

- Debout sur une marche si possible.
- Un pied en appui, l'autre légèrement soulevé.
- Talon en dehors de la marche pour permettre l'amplitude complète.

Exécution

- Monter lentement (2 secondes).
- Descendre lentement (3 secondes).
- Amplitude complète, sans claquement du talon.

Erreurs fréquentes

- Mouvement explosif.
- Amplitude réduite.
- Appui instable.

Progression



Position basse



Position haute

Semaines	Séries	Répétitions
1–2	3	10 / côté
3–4	3	12 / côté
5–6	3	15 / côté

Organisation hebdomadaire

Voici un exemple d'organisation à adapter à votre planning :

Jour	Contenu
Lundi	Footing + exercices
Mardi	Repos ou activité douce
Mercredi	Exercices seuls
Jeudi	Repos
Vendredi	Footing + exercices
Samedi	Sortie longue (selon tolérance)
Dimanche	Repos

Adaptez selon votre emploi du temps. La régularité prime sur la perfection.

Quand recharger progressivement ?

Une fois que la douleur est stable et que les exercices sont bien tolérés, vous pouvez augmenter le volume de course :

Règle d'or

+10 % de volume hebdomadaire maximum, pas plus. Cette règle s'applique à la fois à l'évolution des exercices ET à l'augmentation du volume de course.

Conclusion : reconstruire pour durer

Vous n'avez pas un « mauvais genou ». Votre genou a momentanément perdu sa capacité à tolérer la charge qui lui a été imposée.

La solution n'était pas d'arrêter définitivement. Ni de forcer. Ni de chercher un exercice miracle.

La solution était de comprendre, structurer, progresser.

Vous disposez maintenant :

- D'une compréhension claire du syndrome fémoro-patellaire.
- Des règles pour éviter d'entretenir la douleur.
- D'un plan d'exercices progressif sur 6 semaines.
- D'une stratégie pour continuer à courir intelligemment.

Ce n'est pas un protocole figé. C'est un cadre adaptable.

Ce qui fera la différence

La régularité. Pas l'intensité. Pas la perfection. La constance. Deux à quatre séances de renforcement par semaine. Une gestion intelligente de la charge. C'est ainsi que la capacité revient.

Une vérité importante

La douleur peut fluctuer. Un jour meilleur, un jour plus sensible. Ce n'est pas un échec. C'est le processus d'adaptation.

L'objectif n'est pas zéro sensation. L'objectif est une capacité durable.

Pour aller plus loin



Mot de l'auteur

Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez décidé de ne plus subir. Et c'est déjà un premier pas important.

La douleur antérieure du genou peut être frustrante. Elle freine l'élan, elle fait douter, elle oblige à ralentir. Mais elle n'est pas une fatalité.

Dans mon activité d'ostéopathe, j'ai vu de nombreux coureurs passer par cette phase. Certains étaient débutants, d'autres préparaient un marathon. Tous avaient en commun la même question : « est-ce que je vais pouvoir recourir normalement ? »

La réponse est souvent oui — à condition d'une méthode.

Pour un bilan personnalisé

→ **Réservez votre rendez-vous en cabinet à Lille**

Pour un bilan personnalisé : analyse de foulée, évaluation de la charge, plan de reprise individualisé.

doctolib.fr/osteopathe/lille/maxence-lecointe

Cabinet : 40 rue Royale, 59800 Lille.

Témoignage

Benoit-Charles :

« Très bonne première expérience chez un ostéopathe dont l'objectif était d'effectuer un bilan sportif. Mr Lecointe s'intéresse en détails aux habitudes et ne néglige aucun aspect lors de son analyse. » — Benoit-Charles 35 ans.

Me contacter

- Cabinet : 40 rue Royale, 59800 Lille.
- Itinéraire : maps.app.goo.gl/REedwh2ijmQuvf5C8
- Prise de rendez-vous : doctolib.fr/osteopathe/lille/maxence-lecointe

En cadeau : votre check-list de reprise

Pour vous accompagner au-delà de ce guide, je vous offre une check-list imprimable d'une page à glisser dans votre carnet d'entraînement. Elle reprend les indicateurs à surveiller chaque semaine pour ajuster votre progression.

□ [Télécharger ma check-list gratuite \(PDF\)](#)

Merci de votre confiance.

Bonne course.